Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 5ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810381

Processo nº **0098701-56.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): M. C. B. D.
REPRESENTANTE: ALICE BALTAR D AMBROSIO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos e examinados etc.

MARIA CLARA BALTAR D'AMBRÓSIO, menor impúbere, qualificada na petição inicial e devidamente representada por sua genitora, **Alice Baltar D'Ambrósio**, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR** em face de **BRADESCO SAÚDE S/A**, também qualificada.

Narra a autora: que é beneficiária do plano de saúde empresarial contratado pela empresa D'AMBRÓSIO REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL S/S LTDA; que possui 10 anos de idade com peso de apenas 30,8 Kg, medindo 142 cm (cento e quarenta e dois centímetros); que foi diagnosticada com baixa estatura devido ao déficit na produção natural do hormônio do crescimento (CID E23.0), consoante se atesta do laudo médico subscrito pela endocrinologista-pediatra Marcela Barbosa (CRM-11458/PE), ID 142411292.

Aduz, ainda: que consoante o laudo médico, sem a suplementação do hormônio de crescimento, não vai atingir a média genética e populacional que comumente se espera; que a prescrição indicada pela médica foi no sentido de repor a Somatropina na dose de 0,15UI/Kg/dia, por um período aproximado de 03 (três) anos; que foram indicadas 04 (quatro) opções de medicamentos, quais sejam: (i) Norditropin, 15mg: 3 canetas/mês; ou (ii) Genotropin, 12 mg: 4 canetas/mês; ou (iii) Omnitrope, 15mg: 3canetas/mês; ou (iv) Saizen, 12mg: 4 canetas/mês (Ids 142411292 e 142411293).

Historia que entrou em contato com a Central de Relacionamento da operadora de saúde, sendo informada pelo atendente que o plano não dava cobertura para nenhum dos 4 medicamentos prescritos; que solicitou que lhe fosse enviada uma justificativa por e-mail, mas o atendente se recusou a enviar; que ligou para o SAC

solicitando a negativa por escrito, oportunidade em que foi aberto um "chamado de reclamação" pelo não envio da documentação; que continuou sem receber qualquer outra informação relevante para o tratamento da autora.

Alega que sempre cumpriu pontualmente com as obrigações pecuniárias que lhe competem junto à operadora de saúde; que o tratamento solicitado está devidamente previsto no rol da ANS, integrando a lista de referência básica para cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde; que a ré simplesmente denegou o tratamento sem maiores detalhamentos.

Requereu, por conseguinte, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a fornecer um dos medicamentos prescritos pela médica assistente, nos moldes do laudo médico de ID nº 142411292.

Com a inicial, vieram documentos.

Decisão de ID nº 142664915, onde o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

A parte autora agravou da decisão de ID nº 142664915, e que foi dado provimento ao recurso, reformando a decisão, deferindo o tratamento nos termos requerido.

Em sua contestação, o réu alega, preliminarmente, ausência de documentos indispensáveis para propositura da ação; carência de ação por ausência de pretensão resistida. Requer assim, pela total improcedência dos pedidos autorais, inclusive com o afastamento da condenação em danos morais.

Termo de audiência acostado aos autos, onde não houve qualquer acordo entre as partes.

Réplica nos autos, onde a autora reitera os termos da inicial.

Parecer ministerial em ID nº 1587750627, onde a Promotoria de Justiça opina pela procedência dos pedidos autorais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Ab initio, verifico que a parte ré, em sua contestação, arguiu preliminares.

Passemos a apreciá-las.

Quanto à alegação de ausência de documentos essenciais, tal preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual deve ser analisada em momento oportuno.

Em relação ao argumento de que não houve negativa não pode ser acatado, uma vez que a própria demandada ao longo da peça de defesa tece considerações acerca dos motivos que a levaram a negar o pleito formulado pela autora, chegando, inclusive, a afirmar categoricamente que a cobertura da lente requerida não é devida.

Passo ao mérito.

A presente hipótese dispensa a produção de novas provas, comportando julgamento no estado em que atualmente se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Trata-se de pedido de autorização e custeio do tratamento, com uso de medicamentos, conforme requerido pela médica assistente, por um período aproximado de três anos ou enquanto durar o tratamento para sua enfermidade, qual baixa estatura devido ao déficit na produção natural do hormônio do crescimento (CID E23.0).

A relação jurídica que serve de pano de fundo para a causa de pedir tem indiscutível natureza consumerista. É que o contrato de prestação de serviço operado entre as partes foi materializado entre uma empresa fornecedora de serviços (art. 3º, CDC), e de outro lado, uma pessoa física que adquire o produto como destinatário final (art. 2º CDC).

Assim, evidente a aplicabilidade do CDC ao presente caso.

Resta incontroverso que a autora se encontrava acometida pela enfermidade descrita na exordial, necessitando submeter-se ao tratamento indicado por sua médica assistente, em virtude das sérias consequências que o seu problema pode acarretar.

No caso em apreço, sobressai evidente que, em se tratando de tratamento estritamente necessário e indispensável à manutenção da boa qualidade de vida da autora, a recusa da ré, alegando exclusão de cobertura do contrato, revela-se contrária à natureza do contrato de assistência médico-hospitalar, ameaçando seu objeto e o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, o artigo 51, § 1º, I, da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual relativa ao fornecimento de produtos e serviços que ***restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.***

Com efeito, embora, em princípio, seja lícita, em contratos de fornecimento de produtos ou serviços, a existência de cláusulas restritivas de direitos do consumidor, tais restrições transbordam o limite da legalidade quando atingem proporções capazes de afetar a própria natureza e o objeto do contrato, conforme expressamente previsto no dispositivo legal acima referido.

Igualmente, desmerece chancela a tese de interpretação restritiva dos contratos de adesão formulados pelos planos de saúde, pois, como dito acima, as cláusulas da avença devem ser consideradas e interpretadas em consonância com os ditames do CDC e em benefício do consumidor hipossuficiente.

Não cabe às operadoras de planos de saúde a indicação do tratamento, técnica ou prótese adequado ao paciente/consumidor, tarefa esta que deve necessariamente ser cumprida pelo médico que atendeu o paciente e é quem possui o melhor entendimento acerca da estratégia terapêutica a ser seguida.

Jurisprudência:

EMENTA: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - CRIANÇA COM DÉFICIT DO HORMONIO DE CRESCIMENTO - NEGATIVA DE COBERTURA MEDICAMENTO - MÉDICO ASSISTENTE QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA

INDICAR O TRATAMENTO ADEQUADO – LAUDO QUE EXPLICA QUE O TRATAMENTO É O ÚNICO CAPAZ DE MELHORAR A SAÚDE DA PACIENTE – TUTELA CONCEDIIDA – RECURSO PROVIDO. 1 . É permitido ao plano de saúde estabelecer quais as patologias contratualmente cobertas, mas não pode determinar a forma de tratamento a ser empregada, impedindo a utilização de exames, tratamentos ou medicamentos mais modernos e eficazes à melhoria do estado de saúde da segurada. 2. Cabe ao médico responsável pelo caso, determinar o tratamento apropriado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, desta forma, o plano de saúde não está habilitado, tampouco autorizado, a restringir as alternativas cabíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do enfermo. 3. Restando evidenciado o preenchimento dos requisitos, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada. 4. Recurso provido." – grifei (TJPE, AI nº 0022257-05.2021.8.17.9000, 5ª CC, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, d.j. 16.03.2022)

A questão relacionada ao uso domiciliar do medicamento prescrito não pode servir de lastro para o seu não fornecimento, sob pena da saúde da autora restar prejudicada, desvirtuando assim por completo o espirito do contrato de proteção a saúde firmado com a empresa ré.

O TJPE vem trilhando entendimento semelhante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. TAXATIVIDADE AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DA APELANTE NÃO PROVIDO. 1. O art. 51 , IV , do Código de Defesa do Consumidor , visa manter sempre o equilíbrio contratual. Assim, são vedadas obrigações iníquas (injustas, contrárias à equidade), abusivas (que desrespeitam valores da sociedade) ou que ofendem o princípio da boa-fé objetiva e a equidade (justiça do caso concreto). 2. A recomendação para determinado tratamento é de ordem médica e é o profissional que detém o conhecimento técnico sobre os meios empregados a serem utilizados na cura da doença que acomete o paciente. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se por em risco a vida do consumidor. 3. **A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de considerar a impossibilidade de afastamento do fornecimento de medicamento para uso domiciliar, por parte da prestadora de serviço, devendo a mesma arcar com o medicamento para o**

tratamento indicado para o paciente. 4. Recurso da operadora de saúde não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação APL 2642837 PE) (https://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/625528565/apelacao-apl-2642837-pe)

Os demais tribunais pátrios não discrepam desse posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR- INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. = TRATAMENTO DE CIRROSE HEPÁTICA. - CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O plano de saúde deve fornecer todo o tratamento necessário ao paciente, incluindo aí o fornecimento de medicamento específico e imprescindível para o tratamento com previsão contratual de cobertura, seja este ministrado no âmbito hospitalar ou domiciliar, não cabendo ao Plano de Saúde controlar o uso, mas sim, em ambos os casos, arcar com os custos, a fim de garantir o menor sofrimento possível ao paciente e a consequente sobrevivência digna. 2. **Mesmo o contrato não prevendo o fornecimento de medicamento para uso domiciliar, bem como a Lei de Planos de Saúde e a Resolução Normativa da ANS admitam a exclusão de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, no caso específico dos autos, há de ser interpretado o instrumento contratual em prol do bem maior que é a saúde do consumidor, não sendo pertinente a aplicação dos aludidos dispositivos legais presentes.** 3.São abusivas as cláusulas contratuais que limitam a cobertura do atendimento médico. Precedentes do STJ. 4. O consumidor adimplente tem direito de receber o tratamento médico mais eficiente para o pronto restabelecimento de sua saúde, posto que as normas consumeristas definem que o contrato de seguro de saúde deve ser interpretado para si da forma mais benéfica. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0570978-68.2016.8.05.0001, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/02/2018 (TJ-BA - Apelação 05709786820168050001)

Também não merece guarita a tese de ausência de cobertura em razão de questões relacionadas a taxatividade do rol de procedimentos da ANS.

Importante salientar que, com o advento da Lei 14.454/2022, foi derrubado o chamado “rol taxativo”. O Rol de Procedimentos Médicos da ANS, regra geral, traz lista exemplificativa dos procedimentos com cobertura mínima obrigatória, uma vez que a velocidade de revisão e atualização da referida lista não acompanha os avanços da medicina. Desse modo, não deve o julgador se prender aos procedimentos ali listados, mas analisar os casos apresentados pontualmente.

Em outras palavras, os planos de saúde poderão ser obrigados a financiar tratamentos de saúde ainda que não estejam na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Aqui, para além dos dispositivos legais acima referidos, deve-se observar, especialmente, os princípios da dignidade da pessoa humana, não podendo a seguradora se recusar a autorizar os tratamentos necessitados pelo paciente, quando a sua ausência importar sequelas irreversíveis ao enfermo.

Assim, a meu ver, é ilegítima e abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da forma como foi prescrito para a demandante, pois expressamente solicitado pela médica que a acompanha, com o fito de maximizar a possibilidade de cura.

Assim, havendo cobertura da doença da autora, o plano não pode excluir o tipo de tratamento utilizado e mais adequado para a sua respectiva cura. Havendo previsão de exclusão do tratamento, cuja doença a que se relaciona encontra cobertura, a cláusula contratual correspondente é abusiva, não podendo vigorar.

Dessa forma, uma vez reconhecida a abusividade da negativa do plano demandado, é de consequência inconteste a manutenção da medida antecipatória já deferida, pelo que fica reconhecida a ilicitude da recusa ofertada pelo plano de saúde réu.

Por fim, o dano moral resta configurado, em face do descumprimento da obrigação da seguradora em arcar com as despesas referentes à cobertura do procedimento solicitado pela parte autora, e igualmente em virtude de quebra de confiança depositada pelo consumidor no plano ao qual resolveu se vincular. A ré frustrou a legítima expectativa da autora de obter o tratamento adequado ao seu problema, A recusa injustificada da ré acarretou agravamento da situação psicológica do demandante, causando-lhe mais aflição e sofrimento por ter tido seu direito violado.

Apurado o dano moral experimentado pela demandante, cabe fixar o valor da indenização.

A fixação do valor indenitário, por seu turno, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar-se para as capacidades econômicas da vítima e da parte contrária, para extensão da lesão provocada e para o caráter pedagógico-punitivo da indenização em foco, a fim de que, mediante a sua imposição, o ofensor não venha mais a praticar atos lesivos. O magistrado deve evitar ainda o enriquecimento sem causa do lesionado e a ruína do praticante do ato ilícito. Considerando todos esses pressupostos, bem como, ainda, as circunstâncias advindas do caso concreto, fixo a quantia indenitária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, resolvo **JULGAR PROCEDENTES** os pedidos formulados pela demandante, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para, em consequência, adotar as seguintes providências: a) confirmar integralmente a decisão de tutela deferida em sede de agravo de instrumento de nº 0018235-30.2023.8.17.9000; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo ENCOGE a partir da data deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da efetiva citação; c) condenar ainda a ré a ressarcir ao demandante o valor das custas processuais adimplidas quando do ajuizamento da lide e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% do valor da condenação.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e, verificada a inércia das partes, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa na distribuição.

Recife, 15 de março de 2024

Carlos Eugênio de Castro Montenegro
Juiz de Direito

444

Assinado eletronicamente por: CARLOS EUGENIO DE CASTRO MONTENEGRO
21/03/2024 10:58:12
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 164059370

24032110581207400000160249532

IMPRIMIR GERAR PDF